



Desarrollo de Apps II

Cuatrimestre 2 de 2026

Clase 5 - Actividad Clasificación de Escenarios de Integración

Curso: Lunes, tarde - Grupo 4

Integrantes

Bonarrico, Maximo

Bodas, Agustin

Casanova, Sergio Ariel

Profesor: Ruiz Matias Gabriel

1. Consigna

Para cada uno de los cinco escenarios de MediConecta se identifica qué tipo de integración corresponde (datos, archivos, procedural, portales o procesos), se justifica la elección con al menos un criterio de selección y se indica el riesgo asociado a ese tipo de integración.

2. Clasificación de los escenarios

Escenario A

Cada noche se sincroniza la base de pacientes propia con el padrón de la obra social, mediante un archivo generado automáticamente.

Tipo de integración: Integración por archivos.

Criterio de justificación: El dato no se necesita en el momento: es un intercambio batch programado, de alto volumen, y no requiere exponer ni modificar nada del sistema de la obra social.

Riesgo asociado: Los datos quedan desactualizados entre corridas (ventana de 24 horas). Si el formato del archivo cambia o la corrida falla, el problema recién se detecta al día siguiente.

Escenario B

Al confirmar un turno, se llama en el momento al servicio web de la obra social para validar la cobertura del paciente.

Tipo de integración: Integración procedural.

Criterio de justificación: Se invoca funcionalidad de otro sistema, no se comparten datos, y el resultado se necesita antes de continuar con la operación, por lo que la llamada es sincrónica.

Riesgo asociado: Acoplamiento fuerte en el tiempo. Si el sistema de la obra social está lento o caído, no se puede confirmar ningún turno: la operación completa se cae con él.

Escenario C

El módulo de turnos y el de facturación comparten exactamente la misma base de datos de pacientes, para no duplicar información.

Tipo de integración: Integración de datos.

Criterio de justificación: La integración ocurre a nivel del repositorio compartido. Se busca una única fuente de verdad y evitar duplicación, sin llamadas entre aplicaciones.

Riesgo asociado: Acoplamiento fuerte al modelo de datos. Un cambio de esquema impacta a los dos módulos a la vez, y existe riesgo de contención y de que un módulo corrompa información que el otro necesita.

Escenario D

La recepcionista ve en una sola pantalla la agenda médica, el historial clínico y el estado de pago, aunque vienen de tres sistemas distintos.

Tipo de integración: Integración de portales.

Criterio de justificación: La unificación se resuelve en la capa de presentación. Cada sistema sigue siendo autónomo por debajo y no se integran ni los datos ni la lógica de negocio.

Riesgo asociado: Es una integración solo visual: no hay consistencia transaccional entre los tres sistemas. Si uno responde lento o se cae, la pantalla queda incompleta o desactualizada sin que el usuario lo advierta.

Escenario E

Al terminar una consulta de telemedicina se dispara automáticamente: generar factura, notificar al paciente, actualizar historial y registrar el pago.

Tipo de integración: Integración por procesos.

Criterio de justificación: Hay una secuencia orquestada de pasos entre varios sistemas que forma un flujo de negocio de punta a punta, y esos pasos conviene desacoplarlos y resolverlos de forma asincrónica.

Riesgo asociado: Complejidad en el manejo de errores. Si un paso falla a mitad de camino (por ejemplo, se facturó pero no se actualizó el historial), el proceso queda inconsistente y hay que resolver compensación o reintentos.

3. Síntesis

Escenario	Tipo de integración
A	Archivos
B	Procedural
C	Datos
D	Portales
E	Procesos

De cara a la Segunda Parte del TP, MediConecta utiliza los cinco tipos, pero los que el grupo va a implementar y defender son la integración procedural (validación de cobertura con la obra social vía SOAP) y la integración por procesos (cierre de la consulta de telemedicina resuelto con mensajería JMS).